

【일련번호 5】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 빛고을병원 관리부

【처 분 종 류】 권고

【제 목】 병동 축소에 따른 운영지원직의 효율적 관리 권고

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

빛고을병원 관리부는 병원 운영의 기반 기능을 담당하는 운영지원직의 인력 관리, 업무 조정 및 성과 관리를 통해 진료·교육·연구 활동이 안정적으로 이루어질 수 있도록 지원하는 역할을 수행하며, 운영지원직의 직무체계 수립 및 표준화, 적정 인력 산정 및 배치, 근무 형태 및 근무표 관리, 교육·훈련 및 역량 강화, 성과 평가 및 보상 체계 운영 등 인사·조직 관리 전반을 총괄하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

우리병원 「직제규정」 제3조(직원과 정원) 제3항에 의거 하부조직의 개편과 업무분장의 조정 및 인력관리상 필요한 경우에는 정원을 조정할 수 있고, 임시직원은 예산의 범위 내에서 따로 둘 수 있으며, 「운영지원직근무자 운영규정」 제4조(운영지원직의 구분)에는 병원 운영상 직렬 조정이 필요한 경우 직렬 조정, 단시간제 운영 및 기간제 직원으로 운영이 가능하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 빛고을병원의 운영지원직 인력운영 현황을 점검한 결과, 빛고을병원의 운영 효율화를 위해 병동을 축소하여 발전 방향을 모색하고 있으며, 환자수 또한 줄어들고 있는 상황임을 감안하여 적정 인력운영에 대한 검토가 필요한 사실을 [표5] 와 같이 확인하였다.

[표5] 빛고을병원 운영지원직 인력운영 현황

구분	코로나 이전 (2020년 하반기)		코로나 대응 시기 (2022년 상반기)		병동축소 시기 (2024년 하반기)	
	평균 인원	1인당 월평균 시간외	평균 인원	1인당 월평균 시간외	평균 인원	1인당 월평균 시간외
병원 전체	220.5	5.22	309.8	8.30	251.2	4.33
청소	11	-	11	23.58	9	21.57
보안	4	-	4	45.35	5	31.55
시설	22	-	22	9.68	22	2.62
월평균 환자수	2,399명		1,860명		814명	

※ 참고) 2020년 코로나 이전 시기는 직고용 전이라 운영지원직(청소, 보안, 시설)이 존재하지 않아, 데이터가 없음

4. 판단요지

빛고을병원은 코로나19 등 의료 환경 변화와 지속적인 환자 감소로 인한 경영 여건 악화에 대응하고자 총 4개 병동(51병동, 52병동, 61병동, 62병동) 중 1개 병동(51병동)만 운영하는 등 병동의 단계적 축소 운영 뿐만 아니라 병원 내 기능 이전을 통한 중장기적인 발전 방향을 모색해오고 있다.

* (월평균 환자 수 감소 추세) '20년 하반기(2,399명) → '22년 상반기(1,860명) → '24년 하반기(814명)

이러한 병동축소 및 기능이전은 단순한 공간 조정에 그치지 않고, 간호사 감축을 포함한 직종별 인력 구조 변화 등 병원 운영 전반에 영향을 미치고 있다.

* (빛고을병원 간호직 현원) '20년말(97명) → '22년말(120명) → '24년말(85명) → '26년 1월(65명)

하지만 단순 반복 업무를 주로 수행하는 운영지원직의 경우, 직렬별(환경, 고객, 전산)로 업무량이 감소하거나 업무 범위에 변화가 있음에도 불구하고 코로나19 발생 이전의 인력 규모가 그대로 유지되고 있고 있었으며, 병동 운영 규모, 환자 수 추이, 실제 업무량 분석 등을 통한 적정 인력 운영 방안에 대한 검토 또한 다른 직종에 비해 상대적으로 부족한 실정임을 확인하였다.

2014년 개원한 빛고을병원의 경우 위 [표5] 에서 보듯 코로나 19 감염병 전담병원 지정 전·후로 구분하여 환자수가 급변하였음을 알 수 있다.

코로나19 감염병 전담병원 지정 전까지는 병상 가동률과 환자 수요가 일정

수준 유지되었고, 이후 감염병 전담병원 지정 해제 전까지는 국가적 재난 극복을 위한 인력 투입의 필요성이 인정되었으나, 현재는 병동 축소로 인해 업무량이 감소하였음에도 불구하고 업무량 대비 인력 배치의 불균형이 발생으로 인한 특정 시간대(ex. 조기출근)의 시간외 근무나 휴일 근무가 상시적으로 발생하는 구조가 고착화¹⁾되고 있다고 판단된다.

시간외 근무(휴일 근무 포함)의 지속적인 발생은 인건비 증가를 통해 병원 재정에 중·장기적인 부담을 가중시키는 요인으로 작용한다.

따라서 빛고을병원 관리부에서는 업무량 및 근무 내용에 대한 철저한 분석과 구성원들과의 소통을 통해 근무형태 조정이나 직무 재배치와 같은 업무 효율성을 제고방안을 검토하는 등 자구 노력을 기울였어야 함에도 부족한 점이 있다.

운영지원직의 경우 「운영지원직근무자 운영규정」 제4조(운영지원직의 구분)에 따라 “병원 운영상 필요하다고 판단되는 경우 직렬 조정, 단시간제 운영, 기간제 직원으로의 운영 등 다양한 인력 운영 방식을 허용” 하고 있으므로 규정의 취지를 살려 병원의 경영 환경 변화에 유연하게 대응하고, 인력 운영의 효율성과 탄력성을 확보하기 위한 방안도 적극 검토할 수 있을 것이다.

즉, 빛고을병원 운영지원직 인력 배치의 적정성과 함께 직무조정, 근무형태 다양화, 기간제·단시간제 활용 등 다양한 인력 운영 방안을 종합적으로 검토함으로써 인건비 구조를 합리화하고 시간외 근무 발생 요인을 개선할 필요가 있었다고 판단된다.

물론 빛고을병원 관리부가 인력운용과 관련한 정책을 구현하기에는 몇가지 한계점을 가지고 있다.

첫째, 빛고을병원은 ‘권역별 전문 질환 센터’로서 공공보건의료사업을 수행하는 주관기관이다. 즉, 공공사업을 수행하면서 수익성까지 담보하는 것이 현실

1) 청소반장(1시간 조기출근) : 22년(코로나 대응기) 주 5시간 → 24년 주 5시간 → 25년6월 주 4시간
시설반장(1시30분 조기출근, 30분 연장근무) : 주 10시간(일 2시간)

적으로 어렵다는 점

둘째, 인력의 최종승인권과 노사관계 정책을 본원이 주관하고 있는 현 의사결정구조에서 빚고을병원의 자율적으로 의사결정 또한 어렵다는 점

셋째, 경영의사결정이 주로 과거 경영진에 의해 이루어진 점

넷째, 자본이라는 생산요소와 달리 노동은 1단위를 분할하여 운용할 수 없는 특수성으로 인해 경영상황과 연계한 신속한 인력운용 정책의 수립 및 집행이 어렵다는 점이다. 특히 병동운용 정책과 같은 상위정책 결정이 선행되지 않은 상태에서는 더욱 한계를 가질 수밖에 없을 것이다.

빚고을병원은 2008년 보건복지부 지정 ‘권역별 전문 질환 센터’로 총 657억원(국비 250억원, 시비 110억원, 자체 예산 297억원) 중 360억원의 국민세금이 투입되었음에도 2024년말 이월결손금이 1187억원에 이르는 자본잠식 상태이다.

따라서, 공공사업 수행 주체로서 당초 계획된 사업을 지속적으로 운용함이 사회적 약속 이행에 보다 합목적적임을 고려한다면 위의 한계점에도 불구하고 적극적인 대처 또는 자구노력이 필요했다고 판단된다.

2026년 3월 빚고을병원 기능이전 예고되어 있지만 향후 빚고을병원이 존속하는 동안, 병원 재정 건전성 확보와 지속가능한 운영 기반을 마련하기 위해 자체적으로 효율적 인력 운영 개선 방안을 모색하는 등 보다 적극적인 노력이 요구된다.

【처 분 요 구】

빚고을전남대학교병원장은 병상 축소 및 환자 수 감소라는 운영 환경 변화에 비추어 인력 운영 체계에 대해 재검토가 요구되며, 특히 운영지원직 인력 운영 방안에 대해 병원 운영 규모와 기능 이전에 부합되도록 합리적 대안을 모색하시기 바랍니다. (권고-빚고을병원 관리부)